

Guía clínica: Depresión y Riesgo Suicida

La evaluación del riesgo suicida es una competencia clínica central. Esta guía orienta la evaluación, el manejo y los criterios de derivación o intervención urgente.

■ ■ NOTA CLÍNICA IMPORTANTE

Esta guía es un recurso de orientación clínica general, no un protocolo de evaluación estandarizado. Ante cualquier situación de riesgo real, se recomienda seguir los protocolos institucionales vigentes, consultar con supervisión clínica y actuar con criterio profesional contextualizado.

1. Espectro de la ideación suicida

Ideación pasiva	Deseos de no existir o de 'no estar'. Sin plan ni intención activa.
Ideación activa sin plan	Pensamientos activos de suicidarse, sin un método o momento definido.
Ideación con plan	Pensamientos activos con un método, lugar o momento pensado.
Intención o preparación	Decisión tomada. Preparativos concretos. Riesgo inminente.

2. Factores de riesgo a evaluar

Factores de riesgo	Factores protectores
• Intentos previos (principal predictor).	• Red de apoyo social activa.
• Plan específico y acceso a medios.	• Razones para vivir (familia, proyecto, fe).
• Desesperanza intensa.	• Acceso a tratamiento y buena alianza terapéutica.
• Aislamiento social.	• Capacidad de buscar ayuda.
• Consumo de sustancias.	• Ausencia de acceso a medios letales.
• Impulsividad elevada.	• Compromiso con la seguridad.
• Pérdidas recientes significativas.	

3. Preguntas para la evaluación clínica directa

Preguntar directamente sobre suicidio NO aumenta el riesgo. La evaluación directa y sin rodeos facilita que la persona se sienta escuchada:

- › ¿Has tenido pensamientos de hacerte daño o de no querer seguir viviendo?
- › ¿Con qué frecuencia tenés esos pensamientos? ¿Son muy intensos?
- › ¿Has pensado en cómo lo harías?
- › ¿Tenés acceso a ese medio?
- › ¿Has llegado a preparar algo o a ponerte en una situación de riesgo?
- › ¿Hay algo que te impide actuar? ¿Qué razones tenés para seguir adelante?

4. Criterios para intervención urgente o derivación

Intervención urgente: plan específico con acceso a medios, intención activa o preparativos concretos, estado de agitación o intoxicación que comprometa la seguridad, ausencia de red de apoyo inmediata. En estos casos: no dejar sola a la persona, contactar red de apoyo, derivar a guardia de salud mental.

5. Plan de seguridad (cuando no hay riesgo inminente)

- Identificar señales de alerta tempranas personales.
- Estrategias de manejo interno: qué puede hacer la persona cuando aparecen esos pensamientos.
- Personas de confianza a quienes puede llamar.
- Recursos profesionales de emergencia (línea de crisis).
- Restricción de acceso a medios letales (acuerdo con familia si es necesario).

Registro clínico

Evaluación de riesgo en esta sesión (nivel, factores identificados):

--

Acuerdos y plan de seguridad establecidos:

--